

체외충격파 채팅방 자주 묻는 질문

구성 빈도순 28문항, 7월 현장 문의 반영 · 각 질문에 근거 병기
근거 비급여관리정책협의체 자율가이드라인, 관련 법령·기준

표기 범례

확정 1차 자료로 확인 **참고** 법령·기준으로 정리(개별 확인 권장) **미확인** 공식 답 없음

[참고]·[미확인] 항목은 심평원·해당 기관에 개별 확인이 필요합니다. 체외충격파는 비급여로 유지되며 자율 가이드라인이 적용됩니다.

Q 체외충격파 채팅방 자주 묻는 질문

Q1 7월 1일부터 충격파 횟수가 리셋되나, 기존 횟수가 차감되나?

참고 경과조치가 따로 없어 시행일 이후 기준으로 운영한다.

가이드라인은 부위당 6회·연 12회를 권한다. 기존 횟수를 리셋하는지 차감하는지는 공식 규정이 없고, 실손 적용은 분쟁조정기준과 보험사 안내를 따른다.

근거: 비급여관리정책협의체 체외충격파 자율가이드라인(2026.6.17)

Q2 비급여 충격파 횟수를 타 병원·심평원에서 조회·차감하나?

확정 전국 합산 조회 체계가 없다.

충격파는 급여가 아니라 자율가이드라인(분쟁 심사기준)을 따르므로, 도수치료관리시스템 같은 전국 횟수 차감 장치가 없다. 횟수 관리는 의료기관 기록과 실손 분쟁조정기준으로 이뤄진다.

근거: 비급여관리정책협의체 체외충격파 자율가이드라인(2026.6.17); 금융감독원 실손 분쟁조정기준

Q3 비급여 동의서를 7월 1일부터 의무로 받아야 하나, 양식은?

확정 설명과 동의는 권고되지만 법정 의무 양식·시점은 정해져 있지 않다.

가이드라인은 치료 전 목적·효과·횟수·간격·실손 적용·금기·부작용을 충분히 설명하고 동의를 받도록 권한다. 표준 양식과 의무 시점은 규정이 없어 의료기관·학회 안내를 따른다.

근거: 비급여관리정책협의체 체외충격파 자율가이드라인(2026.6.17) 설명·동의 항목

Q4 충격파 비급여 금액을 타수별로 차등해 받아도 되나, 평균가는?

참고 비급여라 병원이 정하나 적정성은 점검 대상이다.

충격파는 비급여여서 타수·부위별로 금액을 정할 수 있으나 비급여 모니터링과 실손 분쟁조정 대상이다. 표준가는 없고 심평원 비급여 진료비 정보로 지역별 가격을 볼 수 있다.

근거: 비급여관리정책협의체 체외충격파 자율가이드라인(2026.6.17); 심평원 비급여 진료비 정보

Q5 부위당 6회는 좌우를 각각 6회로 보나, 합산인가?

미확인 공식 문서에서 확인되지 않는다.

가이드라인은 부위당 6회·연 12회로만 정하고 좌우를 각각 보는지 합치는지는 명시하지 않아, 실손 분쟁 때 분쟁조정기준 해석을 따른다.

근거: 비급여관리정책협의체 체외충격파 자율가이드라인(2026.6.17)(좌우 구분 명시 없음)

Q6 7개 적응증 외 부위(손목·엄지, 일반 발목 관절통 등)는 불가한가?

확정 의사 판단으로 할 수 있으나 실손이 제한된다.

가이드라인은 7개 적응증 외 질환도 의사 판단하 시행할 수 있되 실손 적용이 제한될 수 있음을 미리 알리도록 한다. 손목·엄지나 일반 발목 관절통은 7부위에 없어 실손 제한 대상이다.

근거: 비급여관리정책협의체 체외충격파 자율가이드라인(2026.6.17) 적응증 항목

Q7 도수치료와 체외충격파를 같은 날 동시 시행·산정할 수 있나?

확정 막지는 않으나 점검 대상이다.

급여 도수와 비급여 충격파의 병행치료를 별도로 제한하지는 않으나, 동시 시술 행위는 별도 모니터링이 진행될 예정이다(질의응답 Q8). 같은 날 시행·청구의 구체 기준은 추후 점검 결과를 따른다.

근거: 심평원 질의응답 수정본(2026.6.29) Q8; 비급여관리정책협의체 체외충격파 자율가이드라인(2026.6.17)

Q8 충격파 받은 날의 물리치료가 도수 선행으로 인정되나?

참고 충격파 자체는 선행이 아니다.

도수 선행은 이학요법료 제1·2절 물리치료를 기준으로 하므로(고시 마목, 질의응답 Q18) 비급여인 충격파는 선행 행위가 아니다. 같은 날 받은 물리치료가 따로 선행 요건을 채웠는지로 판단한다.

근거: 심평원 질의응답 수정본(2026.6.29) Q18; 보건복지부 고시 제2026-136호 도수치료 급여기준 마목

Q9 주사 후 같은 날 충격파를 할 수 있나?

참고 금지 규정은 없으나 점검 대상이 될 수 있다.

주사와 충격파를 같이 하는 것을 막는 규정은 없지만, 실손은 각 항목의 적응증과 약관을 따르고 동시 시술은 모니터링 대상이 될 수 있다.

근거: 심평원 질의응답 수정본(2026.6.29) Q8; 비급여관리정책협의체 체외충격파 자율가이드라인(2026.6.17)

Q10 본인부담(비급여)이면 적응증과 무관하게 어떤 질환이든 가능한가?

확정 시행은 되나 실손은 제한될 수 있다.

가이드라인은 7개 적응증 외 질환도 의사 판단하 시행할 수 있되 실손 적용이 제한될 수 있다고 한다. 전액 본인부담이면 치료는 가능하나 실손은 받지 못할 수 있다.

근거: 비급여관리정책협의체 체외충격파 자율가이드라인(2026.6.17) 적응증 항목

Q11 무료(서비스) 충격파도 환자 유인행위로 불법인가?

확정 충격파는 비급여라 무료 제공 자체가 곧바로 유인행위가 되지는 않는다.

급여의 본인부담금을 면제·할인하면 의료법 제27조제3항 환자 유인행위로 금지되어 벌칙(제88조) 대상이지만, 비급여 비용의 감면은 유인행위로 보지 않는다는 헌법재판소 결정 취지가 있다. 다만 실손·모니터링 위험은 별개다.

근거: 의료법 제27조제3항·제88조; 헌법재판소 결정 취지(비급여 비용 감면은 유인행위 불해당, 사건번호 미확인)

Q12 TKR 등 수술 후 충격파가 적응증·실손 적용이 되나?

확정 7부위 적응증에 맞아야 실손이 된다.

가이드라인의 슬관절 적응증은 슬개건염으로 한정되므로, 수술 후 무릎이라도 슬개건염 등 7부위 적응증에 맞아야 실손 인정 여지가 있고 그 외는 제한될 수 있다.

근거: 비급여관리정책협의체 체외충격파 자율가이드라인(2026.6.17) 적응증 항목

Q13 보험사 약관상 충격파·증식·도수 합산 한도가 있나?

참고 약관마다 다르다.

충격파·증식치료·도수 등 비급여 물리치료의 합산 한도와 자기부담은 보험사 약관이 정하며 세대·상품별로 다르다. 가입 약관을 직접 확인해야 한다.

근거: 보험사 실손 약관

Q14 도수 환자만 충격파를 하나, 단독도 되나?

참고 단독으로도 된다.

충격파는 적응증에 맞으면 도수 여부와 무관하게 단독으로 할 수 있다. 도수와 묶는 것은 병원 운영 방침일 뿐 규정 사항이 아니다.

근거: 비급여관리정책협의체 체외충격파 자율가이드라인(2026.6.17) 적응증 항목

Q15 고강도 힐트(레이저)·라디알 등 기기는 충격파로 청구·분류되나?

참고 항목이 달라 분리된다.

가이드라인은 집속형·방사형(라디알) 체외충격파를 대상으로 하고, 고강도 레이저(힐트)는 원리가 다른 별도 비급여라 충격파 횟수·코드와 분리된다. 개별 코드와 약관 확인이 필요하다.

근거: 비급여관리정책협의체 체외충격파 자율가이드라인(2026.6.17); 비급여 항목 분류(개별 확인)

Q16 충격파 비급여 전환 시 과세·세금 문제가 생기나?

참고 비치료 목적이면 과세될 수 있다.

치료 목적이면 면세이나, 미용 등 비치료 목적 비급여는 과세 대상이 될 수 있다. 도수와 같이 과세 진료를 하면 과세사업자 전환과 세무 확인이 필요하다.

근거: 부가가치세법 제26조(면세) 및 동법 시행령

Q17 충격파도 도수처럼 향후 관리급여로 규제될 가능성이 있나?

참고 모니터링 후 결정될 수 있다.

정부는 충격파를 관리급여와 함께 가격·사용량을 모니터링하겠다고 밝혔다. 추가 규제(가격·횟수 제도화) 여부는 모니터링 결과를 따른다.

근거: 비급여관리정책협의체 체외충격파 자율가이드라인(2026.6.17); 비급여관리정책협의체 회의 자료

Q18 충격파를 다른 비급여에 묶어 시행하면 실손이 지급되나?

참고 권하지 않는다.

비급여를 실손 받으려 다른 항목에 녹이면 보험사 지급 거절·현장조사·분쟁 위험이 있다. 비급여 비용 감면 자체는 유인행위로 보지 않지만, 허위·축소 청구는 별개의 위법이다.

근거: 헌법재판소 결정 취지(비급여 비용 감면 관련); 요양급여·실손 부당청구 일반 기준

Q19 6.16~7.16 신규 국회 청원에 체외충격파 횟수 제한도 포함돼 있나?

확정 포함된다.

신규 국회 국민동의청원(2026.6.16~7.16)은 도수치료 관리급여화 고시와 체외충격파 횟수 제한 정책의 철회·시행유예를 함께 요구한다. 동의 진행 상황은 수시로 바뀐다.

근거: 국회 국민동의청원(2026.6.16~7.16)

Q20 충격파 비급여 동의를 받지 않으면 분쟁·심사에서 불이익이 있나?

참고 실손 분쟁에서 불리할 수 있다.

가이드라인은 설명·동의를 권하고 금융감독원이 이를 실손 분쟁조정기준에 반영한다. 설명·동의를 부실하면 분쟁·민원에서 불리할 수 있으나, 별도 법정 제재 규정은 없다.

근거: 비급여관리정책협의체 체외충격파 자율가이드라인(2026.6.17); 금융감독원 실손 분쟁조정기준

Q21 충격파 주 1회는 월요일부터 일요일까지 주 단위인가, 아니면 7일 간격인가?

참고 가이드라인과 의사협회 안내는 주 1회 시행으로 권한다.

이때 1주를 월요일부터 일요일까지 주 단위로 보는 것이 통상이나, 일부 기관이 유선 문의에서 만 7일 간격으로 안내받았다는 현장 전언이 있어 월~일 주 단위인지 7일 간격인지 공식 문구가 명확하지 않다. 실손 분쟁을 피하려면 보수적으로 7일 간격 또는 주 1회 원칙을 지키고 근거를 기록하는 편이 안전하다.

근거: 비급여관리정책협의체 체외충격파 자율가이드라인(2026.6.17) 주1회; 대한의사협회 안내; 현장 질의(치료사 정보공유방, 2026.7.3, 7일 간격 여부 미확인)

Q22 충격파 횟수도 7월 1일부터 리셋되어 새로 시작하나?

참고 경과조치가 없어 시행일 이후 기준으로 운영한다.

충격파는 급여가 아니라 자율가이드라인(부위당 6회·연 12회)을 따르며 별도 경과조치가 없어, 6월 이전 시행분을 리셋·차감하는지는 공식 규정이 없다. 연 한도의 시작 시점과 합산은 보험사 실손 분쟁조정기준을 따른다.

근거: 비급여관리정책협의체 체외충격파 자율가이드라인(2026.6.17); 금융감독원 실손 분쟁조정기준

Q23 입원환자 충격파도 타수·주 1회 기준이 외래와 같은가?

참고 가이드라인은 입원과 외래를 구분하지 않는다.

부위당 6회·연 12회, 주 1회 권고는 입원·외래 구분 없이 같게 보는 것이 일반적이다. 다만 입원 중 타수나 주기의 세부 인정은 공식 명시가 없어 보험사·심사기준으로 확인해야 한다.

근거: 비급여관리정책협의체 체외충격파 자율가이드라인(2026.6.17)(입원·외래 구분 없음); (참고) 실손 심사기준

Q24 인공관절 등 수술 직후 충격파는 금기인가 가능한가?

참고 의사가 금기·적응증을 판단해야 한다.

충격파는 급성 감염·혈전·종양·성장판·심박동기 등에 금기이며, 인공관절 등 수술 직후는 의사가 금기 여부와 적응증을 판단한다. 슬관절 적응증은 가이드라인상 슬개건염으로 한정되므로 수술 후 무릎이라도 적응증에 맞아야 실손 여지가 있다.

근거: 비급여관리정책협의체 체외충격파 자율가이드라인(2026.6.17) 적응증·금기; 체외충격파 일반 금기기준

Q25 임신부에게 충격파를 하면 금기·실손은 어떻게 되나?

참고 임신은 금기이며 실손도 어렵다.

임신은 체외충격파의 일반적 **금기**로 보아 시행을 권하지 않으며, 임신 관련 골반통·요통 등에 시행한 경우 실손 보상도 어렵다. 시행 전 **금기**와 실손 제한을 충분히 설명해야 한다.

근거: 체외충격파 일반 금기기준; 보험사 실손 약관·분쟁조정기준

Q26 손목·발목 등 7개 적응증 외 부위 충격파가 다시 가능해졌나, 실손은?

확정 의사 판단으로 시행할 수 있으나 실손이 제한된다.

손목·엄지나 일반 발목 관절통 등은 7개 적응증에 없어 **실손이 제한**될 수 있고, 특정 부위가 다시 인정으로 바뀐 것은 아니다. 부위가 다시 가능해졌다는 안내는 공식 근거를 확인해야 한다.

근거: 비급여관리정책협의체 체외충격파 자율가이드라인(2026.6.17) 적응증 항목

Q27 힐트(고강도 레이저)는 충격파 코드·횟수에 포함되나, 인정비급여인가?

참고 힐트는 원리가 달라 충격파와 분리된다.

고강도 레이저(힐트)는 집속형·방사형 체외충격파와 원리가 다른 별도 비급여여서 충격파 횟수·코드와 분리된다. 인정비급여 여부와 코드는 항목 분류와 보험사 약관을 개별 확인해야 한다.

근거: 비급여관리정책협의체 체외충격파 자율가이드라인(2026.6.17); 비급여 항목 분류(개별 확인)

Q28 크라이오·신장분사를 도수·충격파 대체로 하면 되나, 실손은?

참고 별도 비급여이며 실손은 약관을 따른다.

냉각(크라이오)·신장분사 등은 충격파·도수와 다른 별도 비급여로 대체 시행할 수 있으나 실손 보상은 항목·약관에 따라 제한될 수 있다. 비급여를 실손 받으려 다른 항목에 끼워 넣으면 **지급 거절**·분쟁 위험이 있다.

근거: 보험사 실손 약관; 요양급여·실손 부당청구 일반기준